LA PSYCHO-TRAUMATOLOGIE

LAPSUS

Cela faisait un an et demi qu'Adélaïde accueillait Émilie en thérapie, et il s'était déjà passé beaucoup de choses.

Émilie ressentait de nombreuses émotions, particulièrement intenses, qui l'amenaient régulièrement à adopter des comportements agressifs et parfois même violents contre elle-même et son entourage. Sa psychiatre lui avait diagnostiqué un trouble de la personnalité borderline. Pour diminuer ces symptômes, elle avait accepté un traitement médicamenteux, et la psychiatre lui avait également recommandé de suivre une psychothérapie. Elle lui avait communiqué les coordonnées d'un collègue psychologue, mais Émilie refusait d'être reçue par un homme.

Elle avait donc demandé à ses amies si elles connaissaient des femmes psys, et elles lui avaient donné deux noms. Émilie n'avait suivi qu'une séance avec la première : elle ne s'était pas sentie en confiance car la psy lui semblait trop jeune, trop inexpérimentée.

Elle était donc allée voir la deuxième et elles avaient eu une dizaine de séances ensemble. Mais au bout de quelque temps, Émilie avait eu la sensation que la psy ne l'aimait pas et elle n'avait plus réussi à parler honnêtement pendant les consultations. Elle avait fini par arrêter d'y aller. Émilie était parvenue, malgré sa gêne, à envoyer un SMS à cette psy pour lui expliquer en quelques mots que ce n'était pas contre elle, mais qu'elle n'y arrivait pas, désolée. Peut-être pouvait-elle lui recommander une collègue ? La psy avait répondu très gentiment et lui avait suggéré de prendre rendez-vous avec Adélaïde.

Émilie avait tout de suite accroché avec cette très belle dame qui avait le don de la faire se sentir très à l'aise. Adélaïde ne semblait pas perturbée par les remarques parfois un peu piquantes d'Émilie, en tout cas elle ne lui en avait jamais tenu rigueur. Au contraire, elle avait toujours utilisé les réflexions de sa patiente pour tenter de mieux la comprendre afin d'avancer ensemble. C'était la première fois qu'on s'intéressait autant à Émilie et ça lui faisait beaucoup de bien. Cette fois, elle était donc restée.

Cependant, même après plus d'un an d'un travail efficace, Émilie n'avait toujours pas dévoilé à Adélaïde certains événements de son histoire, pourtant importants pour elle. Même si elle était convaincue de la bienveillance de sa psy, certains mots ne passaient pas le seuil de ses lèvres. Elle craignait trop de s'effondrer ou de redevenir violente, ce qui n'était plus arrivé depuis plusieurs mois maintenant.

Puis, un jour, Émilie avait eu le sentiment que c'était maintenant qu'elle devait parler. Une sorte d'intuition qu'elle ne pouvait expliquer mais qui était là, en elle. Toutefois, elle ne savait pas trop comment s'y prendre pour que ce moment ne se transforme pas en calvaire.

Elle avait donc dit :

– Adélaïde, je voudrais vous dire quelque chose. J'essaie depuis plusieurs séances mais je n'y arrive pas. Je ne sais pas comment faire pour y parvenir. Mais je crois que c'est important que je vous le dise.

La psy ne s'était pas formalisée et avait proposé :

– Pourriez-vous l'écrire ?

Émilie avait acquiescé puis avait saisi son téléphone pour envoyer un SMS à sa psy, devant elle. Adélaïde s'était donc levée pour saisir son propre smartphone et lire le message de sa patiente :

> Quand j'avais sept ans, le cousin de mon père m'a obligée à lui toucher les parties. J'ai trop honte.

Après un mouvement de sourcils significatif, qui montrait qu'Adélaïde était touchée par ce qu'elle venait de lire, elle avait simplement dit :

– Merci de votre confiance, je comprends que vous ayez eu du mal à m'en parler.

La bienveillance d'Adélaïde avait tellement soulagé Émilie qu'elle en avait presque pleuré. Puis, la psy avait ajouté :

– Quand vous vous sentirez prête, on pourra traiter ce traumatisme. Pas pour l'oublier, mais pour qu'il ne représente plus une menace émotionnelle pour vous.

C'était il y avait maintenant trois semaines.

LA BIENVEILLANCE D'ADÉLAÏDE AVAIT TELLEMENT SOULAGÉ ÉMILIE QU'ELLE EN AVAIT PRESQUE PLEURÉ.

Mais aujourd'hui serait peut-être le bon jour. Émilie avait commencé la séance en parlant de son rapport aux hommes qu'elle rencontrait grâce à un site de rencontre.

– Si je comprends bien, dit Adélaïde à sa patiente, bien que vous ayez choisi de rencontrer ces hommes, bien que vous ayez déjà discuté avec eux sur internet et par téléphone, au moment où vous vous trouvez face à eux, vous avez l'impression de ne plus être vraiment là. Même si tout se déroule bien. C'est bien ça ?

– Oui, c'est comme si ce n'était plus moi qui étais assise au café avec eux. Par exemple, le dernier, Lucas, franchement, il était super gentil. Il était attentionné, il me posait des questions. Mais je ne ressentais plus rien, et en même temps j'étais paniquée, confirma Émilie. Et ce n'est pas la première fois que ça m'arrive.

– Est-ce que ce serait comme si, à ce moment-là, il y avait plusieurs Émilie ? Par exemple, une qui a très peur et une qui ne ressent rien ? proposa la psy.

– Euh… comment ça plusieurs Émilie ? Vous me faites peur, là. Vous pensez que je suis schizophrène ? s'inquiéta la patiente.

Pour Adélaïde, le fait que chaque personnalité comportait plusieurs facettes était tellement évident qu'elle en oubliait parfois que cela pouvait sembler très étrange pour les patients. Et même, comme c'était le cas présentement avec Émilie, les inquiéter. À cela s'ajoutait la psychophobie, les préjugés à l'encontre des personnes souffrant de pathologies psychiatriques, de sorte que des mots comme « schizophrène », « hystérique » ou « autiste » devenaient dans le langage courant des adjectifs pour dévaloriser des comportements. Qui n'a jamais entendu des remarques comme « T'es schizo ou quoi ? », ou encore « Fais pas ton autiste » ?

L'emploi abusif de ces termes, et l'irrespect à l'égard de la souffrance psychique, participaient à faire croire que les personnes souffrant de problèmes psychiatriques et psychologiques seraient des personnes de moindre de valeur que les autres.

La psy entreprit donc de faire un peu de psychoéducation pour clarifier les termes d'une part, et d'autre part expliquer à sa patiente la façon dont elle envisageait la thérapie :

– Non, je ne pense pas que vous souffriez de schizophrénie. Que notre personnalité compte plusieurs parties ne signifie pas nécessairement que nous soyons malades. En fait, certaines approches psychothérapeutiques considèrent que nous avons tous plusieurs parties ou « états du moi ». Pour ma part, je crois que chaque individu se compose de plusieurs parties qui réagissent chacune différemment à une même situation.

– Comme moi pendant mes rencards, donc. Vous voulez dire que c'est normal ? s'enquit Émilie.

– Oui, tout à fait normal. En fait, cette dissociation serait pathologique si les différentes parties de votre personnalité étaient isolées, si elles ne pouvaient pas communiquer entre elles. Par exemple, quand vous êtes face à une personne autoritaire, une partie de vous se sent comme une petite fille pétrifiée, on va dire qu'une partie Petite fille est là. Mais dans le même temps, vous entendez peut-être dans votre tête une petite voix qui dit…

– Une petite voix ?! Émilie écarquilla les yeux. Vous êtes flippante aujourd'hui, Adélaïde.

– Je ne parle pas d'une petite voix hallucinatoire, juste une partie de vous qui se dirait quelque chose comme « Mais t'es con ou quoi d'être pétrifiée comme ça ! ».

– Ah ben oui, alors dans ce cas, ça m'arrive de me dire ça. Et ce n'est pas grave ? voulut vérifier la patiente.

– Non, pas du tout, c'est même tout à fait normal. Plein de gens vivent ça. L'ambivalence est la norme pour l'être humain, expliqua la psy. Figurez-vous que les études scientifiques actuelles tendent à montrer que ces « parties » seraient en fait des ensembles de connexions cérébrales plus ou moins bien reliées à nos réseaux de mémoire.

Émilie se détendait. Maintenant que sa peur d'être très malade s'évanouissait avec les explications de sa psy, elle commençait à accepter l'idée que plusieurs parties de sa personnalité cohabitaient en elle.

– Bon, dans ce cas, oui, en effet, face à mon rencard, il peut y avoir plusieurs Émilie. Il y en a une qui est figée et une autre flippée. Je dirais même qu'il y en a aussi une qui est cynique, qui se met à trouver le mec nul, moche, trop con, pas à la hauteur. Je l'entends bien fort celle-là, d'ailleurs.

– Ah OK ! Cette partie cynique, on peut l'appeler comme ça, « Partie Cynique » pour que ce soit plus simple quand on en discute ? demanda Adélaïde.

– Oui, d'accord… accepta la patiente qui ne voyait pas tout à fait où sa psy voulait en venir.

– Cette Partie Cynique, est-ce que par hasard vous pourriez prendre quelques instants pour essayer de la visualiser ? Vous pouvez fermer les yeux si c'est plus simple, ou les garder ouverts.

– Je la vois, oui, répondit Émilie.

– Sauriez-vous me dire quel âge elle a, environ ? questionna la psy.

– Je dirais qu'elle est ado. Je ne sais pas, disons quatorze ans.

– Savez-vous ce qu'elle ressent ?

– Elle est désabusée, parce qu'elle est dégoûtée des gens. Au fond, je crois qu'elle est super triste.

– Elle a besoin de quoi, à votre avis ? continua la psy qui notait toutes les informations que lui donnait sa patiente sur cette Partie Cynique.

– Qu'on lui dise que les gens ne sont pas si méchants que ça en réalité.

– Ce serait un besoin de confiance en les autres ?

– Ah oui, totalement.

Adélaïde observa le dessin qu'elle venait de tracer machinalement dans le dossier de sa patiente. C'était un rond. Elle ajouta, à côté du rond :

14 ans, triste +++ et besoin de confiance.

Le rond représentait une partie émotionnelle dissociée.[1]

LE ROND REPRÉSENTAIT UNE PARTIE ÉMOTIONNELLE DISSOCIÉE.

– Vous m'avez dit qu'il y avait aussi en vous une partie qui a très peur. Pouvez-vous la visualiser elle aussi ?

1. Terme issu de la théorie de la dissociation structurelle de la personnalité, approche destinée au traitement des conséquences des traumatismes.

– Oui, réagit Émilie. Elle est plus jeune que la Partie Cynique.

– Dix ans ?

– Non, plus petite encore… Je ne sais pas, elle est genre en CP ou CE1, précisa la patiente.

– On pourrait l'appeler « Partie Apeurée » pour bien l'identifier dans notre travail ? proposa Adélaïde.

– Bonne idée, acquiesça Émilie.

Adélaïde jugea probable l'hypothèse que cette Partie Apeurée représentait les vestiges émotionnels de la petite fille qui avait vécu cet horrible traumatisme à sept ans, et dont sa patiente lui avait parlé quelques semaines plus tôt. Comme il était important de ne pas orienter les perceptions des patients, Adélaïde garda cette interprétation pour elle.

– Vous avez dit qu'elle ressent de la peur, vous confirmez cette impression ?

– Oui, enfin, une peur hyper-forte hein, on est plutôt dans la panique là, rétorqua Émilie.

Adélaïde indiqua, à côté du deuxième petit rond qu'elle avait tracé sur sa feuille :

6-7 ans, panique.

– De quoi a-t-elle besoin selon votre intuition ?

– De sécurité, putain ! cria presque Émilie, des larmes s'échappant de ses paupières fermées.

Pour ne pas laisser durablement sa patiente dans une émotion trop intense qui pourrait nourrir son traumatisme, Adélaïde nota à côté du rond Partie Apeurée :

Besoin de sécurité. Partie Fragile.

La patiente venait de réactiver des émotions fortes, probablement péritraumatiques[1]. Elle avait encore besoin d'apprendre à se stabiliser avant de pouvoir retraiter avec Adélaïde le traumatisme provoqué par l'agression sexuelle – par EMDR par exemple. La psy estima qu'il était préférable qu'elle ouvre les yeux pour se tranquilliser.

1. C'est-à-dire autour du trauma. Les approches de traitement de la dissociation considèrent que les « parties émotionnelles » (en fait, plus scientifiquement, les connexions neuronales) se forment après un ou plusieurs traumatismes dans le but d'isoler des images, pensées, émotions, sensations corporelles issues du trauma et nous en protéger. Les études scientifiques (toujours en cours) semblent suggérer que la dissociation serait la conséquence d'altérations neurochimiques survenant lors d'événements particulièrement intenses émotionnellement. Ces altérations auraient pour conséquence de couper ou ralentir certaines connexions cérébrales.

– Pouvez-vous ouvrir les yeux, Émilie et regarder autour de vous ? demanda-t-elle. Dites-moi combien vous voyez de plantes dans mon cabinet.

Émilie observa, ses larmes avaient disparu, elle semblait très concentrée en tournant la tête de droite et de gauche :

– Quatre, si on compte les fleurs séchées.

– C'est bien ça, convint la psy dans un sourire. Maintenant, voulez-vous bien me parler de votre Partie qui ne sent plus rien, celle dont vous me parliez en début de séance ?

– Je vais l'appeler la Partie Insensible, dit Émilie dans un mouvement de doigts qui fit se rejoindre son pouce et son index, comme pour dire « C'est le nom parfait pour celle-là ».

Adélaïde griffonna un nouveau petit rond :

Partie Insensible.

– Arrivez-vous à déterminer son âge, à peu près ?

– C'est plus dur pour elle, réfléchit Émilie. En fait, comme je la vois, c'est une sorte de statue figée. C'est une personne en pierre avec les yeux dans le vide.

– Elle a l'air plutôt adulte ou enfant ?

– Je pense qu'elle est adulte.

– Donc elle ne ressent rien, c'est ça ? interrogea Adélaïde.

– Oui, c'est le vide total en elle.

Le vide n'est pas une émotion, mais Adélaïde le considérait néanmoins comme telle car elle avait l'habitude que ses patients ayant vécu des traumatismes soient totalement coupés de leurs ressentis, comme pour s'en protéger.

– Dites-moi, si vous le savez, de quoi cette Partie a besoin.

– Elle a besoin… de… mouvement peut-être ? De vie, même, précisa Émilie.

– Bon, maintenant que nous avons mieux fait connaissance avec ces différentes parties de vous, et qui bloquent la situation parce qu'elles ne sont pas d'accord entre elles, nous allons pouvoir les inviter à une réunion lors de notre prochaine séance !

– Une réunion… répéta la patiente, circonspecte.

– Tout à fait. Avec mon aide, vous animerez une réunion sur le thème « Passer une bonne soirée avec un homme », expliqua Adélaïde pendant qu'Émilie se demandait qui, d'elle ou de sa psy, était la plus bizarre.

LA PSYCHOTRAUMATOLOGIE

Dans ce chapitre, Adélaïde travaille avec le système dissociatif.

Il est fréquent que, pour des personnes non initiées, le terme de dissociation évoque des pathologies à la fois très graves et incurables. Mais, pour une grande majorité des patients, ce n'est pas le cas.

Certaines formes de dissociation sont même thérapeutiques et on les utilise en psychothérapie, notamment en hypnose.

La dissociation peut être vue comme un continuum :

- tout à droite, on trouve **la pathologie** désignée dans les manuels de classification et de diagnostic (DSM américain et CIM de l'Organisation mondiale de la santé) comme des troubles dissociatifs. La dissociation y est considérée comme la conséquence de traumatismes ; elle génère de grandes difficultés à la fois émotionnelles, comportementales et cognitives. Le trouble dissociatif le plus grave est le trouble dissociatif de l'identité (différent de la schizophrénie).
- tout à gauche du continuum, on trouve **une dissociation « normale »**, qui correspondrait à différents apprentissages de pensées, d'émotions et de comportements, comme autant de réponses programmées pour réagir aux événements de la vie. Dans ces cas-là, nul besoin de travail thérapeutique.
- entre ces deux extrêmes, on trouve **une grande diversité de dissociations d'intensité variable**, allant de la simple ambivalence à des troubles partiels.

Travailler avec les Parties émotionnelles, plus ou moins dissociées, semble produire de bons résultats. La recherche est toujours en cours sur le fonctionnement de la dissociation et la façon dont ce type de thérapie agit sur le cerveau.

Pour approfondir le sujet :

- *Psychothérapie des traumatismes complexes*, Olivier Piedfort Marin et Luise Reddeman
- *Traiter la dissociation d'origine traumatique*, Cathy Steele, Suzette Boon et Onno van der Hart.